

H 37106 085 6703
WD8764 297965A

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS J37066 71 489DE

DANIEL FRANCISCO DA SILVA

IDADE: 45 anos PESO: 114 ALTURA: 182 PROFISSÃO: Engenheiro.
SINTOMAS: Ronco;
QUEIXAS: Sono ruim; sudorese noturna; Despertar; Arterial cansado
MEDICAMENTOS: Hidroclorotiazida + Losartana;

MÉDICO:

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: ☒ Paz

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 22h

HORA QUE ACORDA: 7h 30'

COCHILHO () SIM (X) NÃO

DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI: IV

IAH: 20.1h

SPO2: 83%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: não

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

IMC:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

faz furo pé e ombro.

14/10/2024. Auto 4 à 12 cmH₂O

Marc Dream Wear (L)

21/10/2024 P= 10,6 cmH₂O

Início atividade física

IAH= 9,5 elh

m uso= 8h06 min

↓ P: 5 à 10,5 cmH₂O

28/10 P= 10,9 cmH₂O

↑ P inicial 11 cmH₂O.

24

IAH= 8,9 elh

m. de uso: 7h 2'

furo= 9.11

gua claudica

18/11 P= 9,9 cmH₂O

P90%= 10,5 cmH₂O

2024

IAH= 4,7 elh

m uso= 7h 38 min.

Auto 7 à 10,5 cmH₂O.

18/12/24 P= 9,9 cmH₂O

P90%= 11 cmH₂O

IAH= 4,2 elh

m uso= 7h 55 min

furo= 18 kg.

Auto 8 à 11 cmH₂O.

27/01/25 P= 9,9 cmH₂O.

P90%= 11 cmH₂O

IAH= 3,3 elh

Auto 8 à 11 cmH₂O.

m uso= 9h30min

Bem Adaptado

furo= 0.

Silvini

14/03
2025

P=11 cm H₂O
IAH= 4,4 e/h
m unv= 8h04 min
fuga= 30 seg.

Queria despertar - pouco ar?
Frente à noite ↑ pero

→ P= 11,5 cm H₂O } quanto perda pero e
atmú finia siu

09/05
2025

P= 11,5 cm H₂O
IAH= 4,5 e/h
m unv= 8 horas
fuga= 0 seg.

hemia umbilical. → evitando esfôrço Abdom

too prong pillow (M)

10/07
2025

P= 11,5 cm H₂O
IAH= 4,6 e/h
m unv= 8h05 min
fuga= 4 seg.

n adaptou pillow (M)

compreu bojo dream wear (M)

Nome: DANIEL FRANCISCO DA SILVA

Data de Nascimento: 8-7-1979

IMC: 32,30

Sexo: Masculino

Data do exame: 12-11-2021

Peso: 107 kg

Altura: 1,82 m

Médico: DR. LEANDRO VIEIRA DE SOUSA

BALBI

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 12-11-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO₂) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 480,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 39,0 e 126,5 minutos. O tempo total de sono foi de 414,0, eficiência de 86,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,9%; estágio N2: 57,4%; estágio N3: 19,7%; sono REM: 21,0%. O índice de despertares foi de 12,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 20,0/hora, sendo elas 32 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 73 hipopnéias. A SpO₂ média foi de 94% e mínima de 83%, permanecendo 0,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 52 - 82 bpm e NREM de 51 - 91 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 20,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO₂=83%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

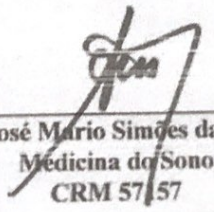
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57